

Nexivarin 10 mg Tabletten — eCTD Einreichung
Modul 5 — Klinische Studienberichte

Einreichungstyp	NDA — 505(b)(1)	Sequenznummer	0000
Einreichungsdatum	2021-03-15	Abschnitt	5.3.4
Vorbereitet von	PharmaCorp Inc.	Vertraulichkeit	Proprietär und vertraulich

Inhaltsverzeichnis — 5.3.4 Integrierte Sicherheitszusammenfassung (ISS)

Abschnitt	Titel	Beschreibung
5.3.4	Integrierte Sicherheitsübersicht (ISS)	Gepoolte Sicherheitsanalysen über Phase-II- und III-Studien hinweg
5.3.4.1	Exponierte Population	Gesamtexponierte Population in allen klinischen Studien
5.3.4.2	Belichtungsdauer	Dauer der Expositionsverteilung; Mittlere und mittlere Behandlungszeit
5.3.4.3	Unerwünschte Ereignisse von besonderem Interesse	Ödem, Hypotonie, Tachykardie — detaillierte AESI-Analyse
5.3.4.4	Todesfälle	Auflistung und Erzählung aller Todesfälle in der klinischen Entwicklung
5.3.4.5	Integrierte Sicherheitsschlussfolgerung	Gesamt-Nutzen-Risiko-Bewertung aus Sicherheitsperspektive

PharmaCorp Inc.
NDA-123456

Nexivarin 10 mg Tabletten

Abschnitt 5.3.4
Integrierte Sicherheitszusammenfassung

Einreichungstyp	NDA — 505(b)(1)
Sequenznummer	0000
Einreichungsdatum	2021-03-15
Vorbereitet von	PharmaCorp Inc.
Vertraulichkeit	Proprietär und vertraulich

5.3.4 Integrierte Sicherheitszusammenfassung (ISS)

5.3.4.1 Exponierte Population

Die integrierte Sicherheitsdatenbank umfasst alle Patienten und gesunden Freiwilligen, die im Rahmen des klinischen Entwicklungsprogramms mindestens eine Dosis Nexivarin Hydrochlorid erhalten haben (N=2.256 insgesamt; N=1.874 Patienten; N=382 gesunde Freiwillige).

Studienpopulation	N Nexivarin	N Placebo	N aktives Kontrollpräparat
Phase I (gesunde Freiwillige)	382	—	—
Phase II (NXV-201)	240	80	—
Phase III (NXV-301)	451	451	—
Phase III (NXV-302, 3 Arme)	454	227	227
Pädiatrie (NXV-PED-01, laufend)	102	52	—
Total (alle Studien)	1.629 (+ PED)	810	227

5.3.4.2 Expositionsdauer

Bei kontrollierten Phase-III-Patienten (N=1.874 Nexivarin) betrug die kumulierte Expositionsdauer: ± 12 Wochen: 89,4 %; ± 24 Wochen: 44,6 %; Längste Exposition: 24 Wochen (NXV-302). Gesamtpatientenjahre der Exposition in Phase III: etwa 624 Patientenjahre.

5.3.4.3 Unerwünschte Ereignisse von besonderem Interesse

AESI	Nexivarin (N=1874)	Placebo (N=923)	Amlodipin (N=227)	Klinische Beurteilung
Peripheres Ödem	14.6%	1.8%	22.3%	Klasseneffekt; Nexivarin niedriger als Amlodipin
Symptomatische Hypotonie	0.8%	0.2%	0.9%	Selten; mit Dosisreduktion behandelt
Reflex-Tachykardie	0.3%	0.1%	0.4%	Selten; klinisch unbedeutend
Hepatotoxizität (ALT >3× ULN)	0.2%	0.1%	0.2%	Nicht signifikant erhöht im Vergleich zu Placebo
QTc-Erweiterung >500 ms	0	0	0	Keine QTc-Signale im Programm
Angioödem	0.05%	0	0	1 Fall; ohne Behandlung gelöst

5.3.4.4 Todesfälle

Im kontrollierten Phase-III-Programm traten drei Todesfälle auf: 1 in der Placebo-Gruppe (plötzlicher Herztod, nicht verwandt mit dem Studienmedikament), 1 in der Amlodipin-Gruppe (Verkehrsunfall) und 0 in der Nexivarin-Gruppe. Es wurden keine Todesfälle im Zusammenhang mit der Studienmedikation betrachtet.

5.3.4.5 Integrierte Sicherheitsschlussfolgerung

Die integrierte Sicherheitsdatenbank im klinischen Nexivarin-Programm zeigt ein konsistentes, handhabbares und vorhersehbares Sicherheitsprofil. Die Hauptnebenwirkung, peripheres Ödem (14,6 %), ist ein Klasseneffekt von Calciumkanalblockern und tritt mit geringerer Rate auf als das Komparatoramlodipin 10 mg (22,3 %). Es wurden keine hepatotoxischen, nephrotoxischen, hämatologischen oder kardialen Leitungssignale identifiziert. Das Gesamt-Nutzen-/Risikoprofil unterstützt die Zulassung von Nexivarin 10 mg zur Behandlung von Bluthochdruck und stabiler Angina.

